

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ART. 75, VIII, LEI N.º 14.133/2021

Processo Administrativo n.º 2026.00003

Justificativa de Situação Emergencial

Aquisição de Autoclave Hospitalar a Vapor
Central de Material e Esterilização — CME
Hospital Municipal Vó Mundoca — Borba/AM

Secretária de Saúde:	Cíntia Roque da Silva Felipe — Decreto n.º 0004/2025-GPMB
Diretor Hospitalar:	Daniel Gomes Vinhote — Decreto n.º 0630/2026
Valor estimado:	R\$ 200.000,00 — Emenda Parlamentar Estadual (ALEAM)
Rel. de Inoperância:	05 de março de 2026
Elaborado em:	Borba/AM, 15 de março de 2026



Quadro de Identificação do Processo

Processo	2026.00003
Unidade solicitante	Secretaria Municipal de Saúde — Borba/AM
Setor / local	Central de Material e Esterilização (CME) — Hospital Municipal Vó Mundoca
Secretária de Saúde	Cíntia Roque da Silva Felipe — Decreto n.º 0004/2025-GPMB
Diretor Hospitalar	Daniel Gomes Vinhote — Decreto n.º 0630/2026
Objeto	Aquisição de autoclave hospitalar a vapor, tipo B (pré-vácuo), câmara ≥ 100 L, com periféricos, logística CIF Borba/AM, qualificações QI/QO/QD e treinamento
Equip. substituído	Autoclave n.º 6897 — Phoenix Luferco — fab. 2019 (~6 anos de uso)
Fundamento legal	Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021 — Dispensa por emergência
Fonte de recursos	Emenda Parlamentar Estadual — Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM)
Valor estimado	R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Rel. de Inoperância	05 de março de 2026 — Relatório Técnico de Inoperância/Insuficiência, Diretor Hospitalar



1. Fundamento Legal

BASE LEGAL

Art. 75, VIII — “É dispensável a licitação [...] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas [...] e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial.”

A presente Justificativa fundamenta-se no art. 75, VIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021. Os elementos fáticos demonstram o preenchimento **cumulativo** dos quatro requisitos:

1. **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão da Administração;
2. **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais de saúde**;
3. **Comprometimento da continuidade de serviço público essencial de saúde**; e
4. **Objeto delimitado ao estritamente necessário**.

2. Caracterização do Município e Vulnerabilidade Geográfica

O Município de Borba, situado na calha do Rio Madeira, possui **34.869 habitantes** no perímetro urbano (IBGE 2025), estendendo sua responsabilidade assistencial a aproximadamente **44 mil pessoas**, incluindo comunidades ribeirinhas e aldeias dispersas ao longo do médio Madeira. A realidade amazônica impõe ao **Hospital Municipal Vó Mundoca** o papel de **unidade de referência isolada**. Remoções aeromédicas ou fluviais até Manaus frequentemente superam 24 horas — tornando a autossuficiência tecnológica da unidade não apenas uma meta administrativa, mas um **imperativo de Segurança Pública e Sanitária**.

ISOLAMENTO E IRREVERSIBILIDADE DO DANO

Em Borba, uma infecção cirúrgica grave não pode ser resolvida por transferência rápida. O traslado fluvial até Manaus varia de **15 a 40 horas**. Uma sepse pós-operatória sem tratamento especializado imediato representa **risco de óbito evitável** — risco inexistente em municípios com rede hospitalar plural.

3. Histórico Operacional e Dimensionamento da Demanda (2025)

A necessidade de capacidade mínima de **100 litros** é ratificada pela expressiva atividade assistencial de 2025. O Hospital Vó Mundoca realizou:

- **4 (quatro) grandes mutirões de cirurgias**, incluindo procedimentos de média complexidade e **cirurgias oftalmológicas especializadas**;
- **Fluxo ininterrupto de partos** — único serviço de obstetrícia de toda a área de influência;
- **Urgências traumáticas e clínicas** 24 horas por dia.

A CME opera em **regime de saturação operacional**. O parque tecnológico atingiu seu **limite de fadiga material**, conforme documenta o Relatório Técnico de Inoperância/Insuficiência de 05/03/2026. A especificação de 100 litros não é restritiva — é requisito funcional demonstrado pela demanda real.



4. Fato Gerador — Diagnóstico Técnico do Equipamento

4.1 Identificação do Equipamento Inoperante

Nº de patrimônio	6897
Fabricante	Phoenix Luferco
Ano de fabricação	2019 (~6 anos de uso em CME de alta demanda)
Tipo	Autoclave hospitalar a vapor — câmara única
Status atual	INOPERANTE — falha sistêmica múltipla
Relatório técnico	Relatório de Inoperância/Insuficiência — 05/03/2026 — Daniel Gomes Vinhote, Decreto n.º 0630/2026 — Anexo II

4.2 Falhas Técnicas Identificadas

F1**Salto de etapas do ciclo de esterilização**

O equipamento transita diretamente da fase de esterilização para a secagem sem concluir o tempo de *plateau*. Essa falha **invalida a garantia de esterilidade** de todos os artigos processados, impedindo o alcance do SAL de 10^{-6} exigido pela RDC ANVISA 15/2012.

F2**Não atingimento da temperatura mínima de esterilização**

O equipamento falha em alcançar **134 °C ± 1 °C**. O Valor F_0 fica abaixo do mínimo de **15 minutos**:

$$F_0 = \int_0^t 10^{\frac{T-121.1}{z}} dt \quad T = \text{temperatura (°C)} \quad z = 10 \text{ °C} \quad (G. \text{stearothermophilus})$$

Com temperatura insuficiente, os artigos são microbiologicamente inseguros mesmo após ciclo completo.

F3**Falha no sistema hidráulico de abastecimento automático**

Entrada de água inoperante — intervenção manual obrigatória a cada ciclo, comprometendo: (i) a **padronização** dos ciclos; (ii) a **rastreabilidade** (RDC 15/2012, art. 34); e (iii) a **segurança do operador**.

F4**Instabilidade geral — falha sistêmica múltipla**



Comportamento errático com parâmetros de pressão e temperatura inconsistentes. A coexistência de F1–F3 confirma **degradação estrutural simultânea** em múltiplos subsistemas, irreversível por manutenção pontual.

5. Biossegurança, CCIH e Controle de Infecções

A aquisição é condição obrigatória para o cumprimento dos protocolos da **CCIH** e do **NSP** do Hospital Vó Mundoca. A inoperância do equipamento inviabiliza os indicadores biológicos e químicos exigidos pela RDC ANVISA 15/2012, elevando o risco de contaminação cruzada, surtos pós-operatórios e IRAS por **microrganismos multirresistentes** (MRSA, KPC, Acinetobacter).

ÔNUS FISCAL INDIRETO DA NÃO AQUISIÇÃO

O custo de uma única internação prolongada por ISC multirresistente pode superar **R\$ 50.000,00**. Além do dano humano irreparável, a omissão expõe o Município à **judicialização por dano ao paciente** — responsabilidade solidária do ente público (CF/88, art. 37, § 6.º).

6. Caracterização da Situação de Emergência

6.1 Impactos Operacionais e Risco de Desassistência

- **Redução crítica da capacidade de esterilização** de instrumentais médico-cirúrgicos;
- **Risco de desabastecimento** para o centro cirúrgico, **centro obstétrico**, pronto-socorro e internação;
- **Violação direta da RDC ANVISA 15/2012**, arts. 5.º, 6.º e 34;
- Em caso de falha definitiva: **paralisação compulsória do centro cirúrgico e obstétrico** — colapso em cidade sem hospital alternativo.

6.2 Risco Sanitário e Responsabilidade Institucional

CADEIA CAUSAL — FALHA DE ESTERILIZAÇÃO → DANO AO PACIENTE

Falha sistêmica → $SAL > 10^{-6}$ → **artigo crítico inseguro** → contato com sítio cirúrgico ou obstétrico → **ISC ou infecção puerperal** → sepse, **óbito evitável** — em Borba, a mais de 24h fluviais de UTI de referência.

A operação com equipamento inoperante sujeita o Município a **interdição sanitária**, sanções administrativas ao gestor e **responsabilidade civil solidária** por danos. O **Princípio da Continuidade** é violado: esterilização é atividade-meio essencial para preservação da vida (CF/88, art. 196).

6.3 Impossibilidade de Aguardar o Rito Licitatório Regular

Etapa do Pregão Eletrônico	Prazo mín.	Observação
ETP + TR + pesquisa de preços	15 dias	Já concluídos



Elaboração do edital (CPL + PGM)	10 dias	
Publicação PNCP até abertura (art. 55, § 2.º)	8 dias	
Propostas + sessão + habilitação	15 dias	
Recursos + homologação + assinatura	10 dias	
Entrega Técnica — período de seca	90 dias	Ago–Nov: balsas de menor calado

Total estimado até Entrega Técnica: ≈ 148 dias (≈ 5 meses)**CME sem esterilização segura**

7. Inviabilidade da Manutenção Corretiva

1. **Falha em quatro subsistemas simultâneos** — degradação estrutural, não pane pontual;
2. **Paralisação adicional durante o reparo:** imobiliza o único equipamento, agravando o risco durante todo o período;
3. **Custo estimado em 60–75% do valor de substituição**, sem garantia de desempenho nem recomposição da garantia;
4. **Ausência de qualificação pós-reparo:** sem nova QI/QO/QD, o SAL permanece incerto;
5. **Fadiga material acelerada:** 6 anos de operação intensiva em UR ≥ 80%.

POR QUE ESTA EMERGÊNCIA NÃO DECORRE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA

O TCU e o TCE-AM exigem que a emergência não seja fruto de negligência. No presente caso: (i) equipamento adquirido regularmente em 2019; (ii) falha sistêmica progressiva, abaixo do horizonte de vida útil esperado; (iii) Emenda Parlamentar ativada; e (iv) falha **documentada tempestivamente** em Relatório Técnico formal em 05/03/2026.

8. Eficiência e Economicidade (Art. 37, CF/88)

A aquisição de equipamento novo é a solução mais econômica em perspectiva sistêmica:

- **Custo acumulado de manutenções paliativas** sem resolução definitiva;
- **Desperdício de insumos** por ciclos com SAL > 10⁻⁶ — descarte de IB e IC;
- **Passivo de responsabilização civil:** uma ISC multirresistente pode superar R\$ 50.000,00;
- **Previsibilidade orçamentária:** 24 meses de garantia + QI/QO/QD documentada.



9. Planejamento Estratégico e Metas para 2026

Para 2026, a Secretaria planejou a **expansão do acesso cirúrgico** e redução das **filas reprimidas**. A manutenção desse cronograma depende da modernização da CME — incluindo mutirões em comunidades ribeirinhas (saúde itinerante) e expansão da **resolutividade cirúrgica local**.

10. Especificação Técnica Justificada

Baseada na RDC ANVISA 15/2012, ISO 17665-1:2006 e EN 285:2015. Todos os requisitos são necessários e suficientes — sem especificação restritiva à concorrência.

Especificação	Requisito Mínimo e Justificativa
Tipo	Autoclave a vapor saturado, *Tipo B (pré-vácuo)*, horizontal — obrigatório para artigos porosos e com lúmens (RDC 15/2012, art. 15)
Câmara	Capacidade útil ≥ 100 litros;* aço inoxidável *AISI 316L* — justificada por 4 mutirões + partos + urgências em 2025; resistência a cloretos e UR $\geq 80\%$
Sistema de vácuo	Bomba de anel líquido; pressão absoluta ≤ 30 mbar; mínimo 3 pulsos* — único método eficaz para materiais porosos e lúmens (EN 285:2015, item 8)
Temperatura	105 °C a 135 °C com precisão ± 1 °C* — $F_0 \geq 15$ min e SAL 10^{-6} (ISO 17665-1:2006)
Programas	Mínimo *13 programas:* poroso 134 °C, sólido 134 °C, líquido 121 °C, Bowie-Dick e Leak Test integrados
Interface e rastreabilidade	Tela colorida *touchscreen;* impressora integrada de ciclos — art. 34 da RDC ANVISA 15/2012
Abastecimento d'água	*Automático* — elimina a falha F3; garante padronização e rastreabilidade
Proteção e segurança	Gabinete elétrico *IP 54;* mínimo *10 sistemas de segurança* incluindo antiesmagamento de porta
Periféricos incluídos	Osmose reversa 60 L/h ($\leq 1,3$ $\mu\text{S}/\text{cm}$); compressor ar médico isento de óleo ≥ 50 L (ABNT NBR ISO 7396-1:2011); racks AISI 316L ≥ 3 un.; carro inox; IB G. stearothermophilus (cx 50 un.); IC Cl. 5 (cx 200 un.); peças de desgaste 12 meses
Qualificações	*QI + QO + QD* (ISO 17665-1:2006) no CME; $\Delta T \leq 2$ °C; IB negativos; $F_0 \geq 15$ min — condição inafastável do TRD
Logística	*CIF Borba/AM + Entrega Técnica* — frete fluvial Manaus–Borba, seguro Ad Valorem, embalagem antivibração



Treinamento	Mínimo *8 horas* presenciais no CME; certificados nominais — operação, manutenção preventiva, monitoramento e rastreabilidade
Garantia e AT	Mínimo *24 meses* a contar do TRD; atendimento no AM $\leq$ *72 horas;* solução definitiva $\leq$ *15 dias corridos*
Registro ANVISA	Obrigatório — registro ativo para o equipamento ofertado
RENEM / CATMAT	Equipamento na RENEM com código CATMAT — Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025

11. Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos

Custeado com **Emenda Parlamentar Estadual (ALEAM)**, execução via **Transferegov** (Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025). Recursos de aplicação vinculada à saúde — sem desvio de objeto.

Componente	Valor (R\\$)	%
Autoclave hospitalar $\geq$ 100 L com barreira sanitária	120.000,00	60,0%
Periféricos (osmose, compressor, racks, carro, IB, IC)	35.000,00	17,5%
Logística CIF Borba/AM + seguro Ad Valorem	15.000,00	7,5%
Entrega Técnica (QI/QO/QD) + Treinamento (8h)	10.000,00	5,0%
Peças de desgaste e consumíveis — 12 meses	15.000,00	7,5%
Contingência logística — sazonalidade Rio Madeira	5.000,00	2,5%
Total — Emenda Parlamentar	200.000,00	100%

A reserva de **R\$ 20.000,00** para adequação da infraestrutura do CME (rede elétrica trifásica, ponto hidráulico e exaustão) é **recurso municipal próprio, adicional e segregado** da Emenda Parlamentar.

12. Prazo da Contratação

Fornecimento de **bem permanente** — contrato limitado a **1 (um) ano** (art. 75, VIII). Prazo de entrega conforme período hidrológico do Rio Madeira:

Período	Meses	Condição Hidrológica	Prazo Máximo
Cheia plena	Jan–Mai	Navegação plena; balsas de grande calado	60 dias corridos



Vazante	Jun–Jul	Restrições incipientes; monitoramento necessário	75 dias corridos
Seca extrema	Ago–Nov	Balsas de menor calado obrigatórias (ANA)	90 dias corridos
Enchente	Dez	Normalização progressiva	75 dias corridos

É **vedada a prorrogação** do contrato emergencial e a recontratação do mesmo fornecedor (*in fine* do art. 75, VIII).

13. Requisitos Formais da Dispensa (Art. 72, Lei 14.133/2021)

	Documento	Artigo	Status
①	Esta Justificativa de Situação Emergencial	Art. 72, I	Elaborada — Anexo I
②	Relatório Técnico de Inoperância — Diretor Hospitalar	Art. 72, I	Elaborado — Anexo II (05/03/2026)
③	Termo de Referência com especificações técnicas	Art. 72, III	Elaborado — Anexo III
④	Pesquisa de preços — mínimo 3 cotações formalizadas	Art. 72, IV	A realizar — modelo Anexo IV
⑤	Planilha comparativa e seleção fundamentada	Art. 72, VII	A elaborar após cotações
⑥	Confirmação de disponibilidade orçamentária da emenda	Art. 72, VI	A juntar — confirmação ALEAM
⑦	Contrato de Fornecimento	Art. 72, VIII	Minuta — Anexo V
⑧	Publicação no PNCP em até 10 dias úteis	Art. 174	Após assinatura

ATENÇÃO

Dispensas por emergência são alvo prioritário de auditoria pelo TCE-AM. Riscos mais comuns de glosa: (i) pesquisa de preços com menos de 3 cotações válidas; (ii) urgência fundada apenas em declarações genéricas, sem Relatório Técnico objetivo; (iii) equipamento não consta da RENEM; (iv) ausência de publicação no PNCP em 10 dias úteis.



14. Conclusão e Recomendação

A urgência aqui caracterizada é **objetiva, concreta e atual**. A aquisição da autoclave é o instrumento jurídico e técnico que permitirá ao Hospital Vó Mundoca honrar o pacto do SUS com a população borbense.

- ✓ **Situação emergencial concreta, documentada e não provocada por omissão:** autoclave n° 6897 (Phoenix Luferco, 2019) em falha sistêmica múltipla — Relatório de 05/03/2026, Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026).
- ✓ **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais,** com potencial para ISC, infecção puerperal, IRAS e óbito evitável — amplificado pelo traslado de 15 a 40 horas até UTI de referência.
- ✓ **Comprometimento da continuidade do serviço público,** com risco de paralisação do centro cirúrgico e obstétrico em município sem hospital alternativo.
- ✓ **Inviabilidade da manutenção corretiva,** inclusive pela paralisação adicional do único equipamento durante o reparo.
- ✓ **Eficiência e economicidade:** manutenções paliativas + desperdício por ciclos falhos + passivo de judicialização superam o investimento em ativo novo com 24 meses de garantia.
- ✓ **Objeto delimitado ao estritamente necessário** — capacidade de 100 L ratificada por 4 mutirões + partos + urgências em 2025.

Recomenda-se a **imediata abertura do procedimento de contratação direta**, com publicação do aviso de dispensa no PNCP (art. 72, III) e instrução com os documentos da Seção 13.

Borba/AM, 15 de março de 2026

Cíntia Roque da Silva Felipe

Secretária Municipal de Saúde
Decreto n.º 0004/2025-GPMB

Daniel Gomes Vinhote

Diretor Hospitalar
Hospital Municipal Vó Mundoca
Decreto n.º 0630/2026

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021, arts. 72 e 75, VIII • RDC ANVISA n.º 15/2012 • ISO 17665-1:2006 (validação calor úmido) • EN 285:2015 (esterilizadores a vapor) • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 (ar médico) • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025 • CF/88, arts. 37, § 6.º, e 196.